

Identyfikator: PAC-088
Wiek/Płeć: 24 lata, Mężczyzna
Tryb przyjęcia: Ambulatoryjny, planowy

Wywiad (S):

Pacjent wysoce aktywny fizycznie zgłasza się po nagłym urazie skrętno-zmiażdżeniowym dolnego aparatu ruchu, do którego doszło 3 tygodnie temu podczas gwałtownego hamowania na murawie. Zgłasza nasilone dolegliwości bólowe, powtarzające się uczucie "uciekania" kończyny pod obciążeniem oraz epizody mechanicznego blokowania pełnego zakresu wyprostu. W wywiadzie masywny wysięk w pierwszych dobach po incydencie.

Badanie fizykalne i diagnostyka (O):

Manualnie stwierdzono wyraźną niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej (nadmierne przesunięcie przednie) oraz dodatnie objawy kompresyjne. Dostarczona dokumentacja z obrazowania polem magnetycznym (MRI) potwierdza całkowite przerwanie ciągłości głównej taśmy więzadłowej wewnątrz torebki. Dodatkowo uwidoczniono podłużne pęknięcie rogu tylnego wewnętrznej struktury włóknisto-chrząstnej (amortyzatora stawowego) oraz stłuczenia tkanki kostnej (bone bruise).

Zalecenia i plan (P):

Z uwagi na zapotrzebowanie biomechaniczne pacjenta i ryzyko przedwczesnych zmian degeneracyjnych, zalecono interwencję naprawczą. Kwalifikacja do małoinwazyjnego wżernikowania wnętrza przestrzeni stawowej z użyciem toru wizyjnego. Planowane operacyjne odtworzenie przerwanej struktury stabilizującej z wykorzystaniem autologicznego przeszczepu ścięgna oraz próba naprawy pękniętej struktury amortyzującej dedykowanym systemem szwów. Wydano skierowanie na blok operacyjny.